VISIONSEEK

VISIONSEEK LAB · REPORTS · HEALTH AI

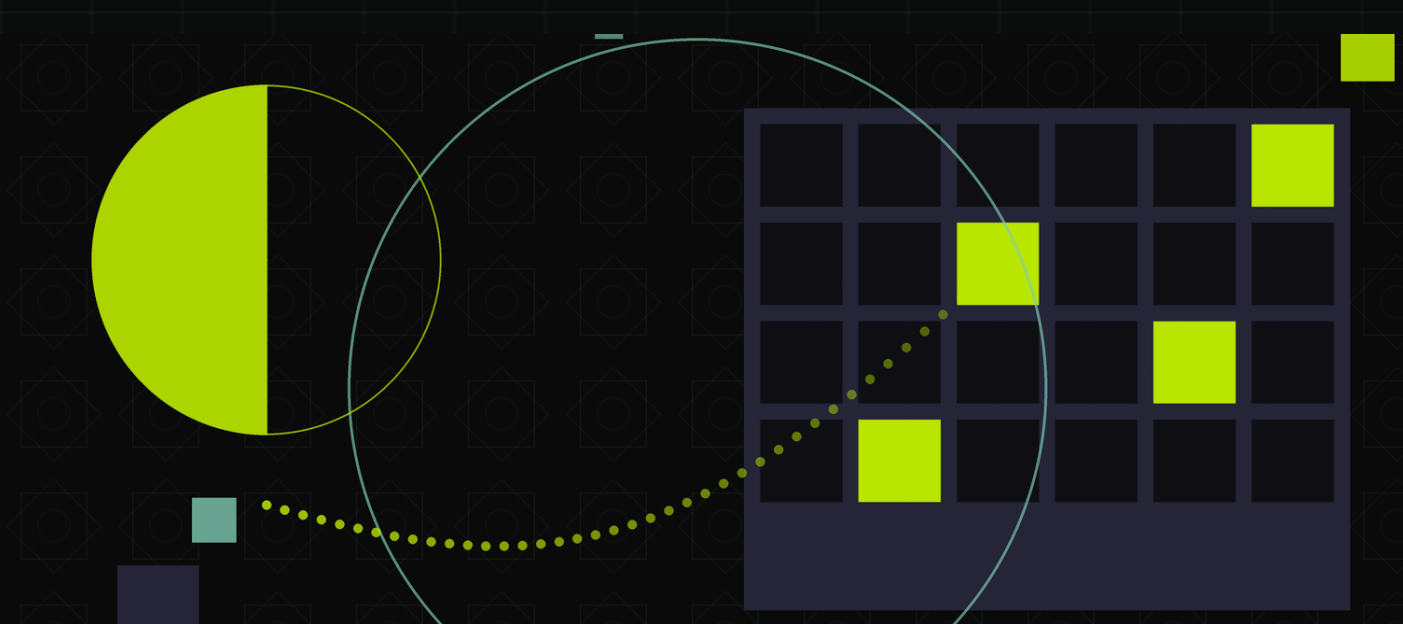
الذكاء الاصطناعي في مستشفياتنا: نحن ندفع، والمورّد هو الذي يتعلّم

ست شراكات ذكاء اصطناعي في مستشفيات الخليج خلال ستة أيام، ولا نص معلن يحدد لمن تؤول نتائج التجربة. ماذا يكتب مجلس الإدارة قبل أول مريض؟

27 أكتوبر 2026

إعداد: أحمد عبدالعليم، VisionSeek (إنتشون، كوريا الجنوبية)

مبني على بحث أجرته VisionSeek



لو دخلت مستشفى كبيرًا في أبوظبي أو دبي هذه الأيام، فقد تجد تقنية ذكاء اصطناعي أجنبية تُجرَّب على المرضى.

شركة تأتي بالأداة، والمستشفى يقدّم المرضى والبيانات ووقت الأطباء، ثم يُعلن الطرفان «شراكة».

يبدو الأمر صفقة رابحة للجميع. لكن هناك سؤالًا لا يطرحه أحد تقريبًا.

عندما تنتهي التجربة، ماذا يبقى في يد المستشفى؟

الجواب باختصار: نحن ندفع ثمن التجربة، والمورّد يأخذ ما تعلّمه

الجواب: صارت مستشفيات الخليج ساحةً مفضّلة لشركات الذكاء الاصطناعي العالمية كي تثبت فيها أن منتجاتها تعمل. وهذا مكسب حقيقي للمرضى.

لكن التجربة تنتج أيضًا ثلاثة أشياء لها ثمن: **الأدلة** السريرية، و**التحسينات** التي تدخل على النموذج من بياناتنا، و**الخبرة** التي يكسبها الفريق.

رصدنا ست شراكات من هذا النوع بين 21 و26 أكتوبر 2026. وفي نصوصها المعلنة لم نجد سطرًا واحدًا يقول لمن تؤول هذه الأشياء.

يعني: على مجلس إدارة المستشفى أن يكتب الملكية في مذكرة التفاهم قبل أول مريض، لا في عقد التوسع بعد نجاح التجربة.

ماذا حدث في أسبوع واحد؟

الموجة حقيقية وسريعة. في قمة أبوظبي للصحة المستقبلية وبعدها بأيام:

- تحقق سريري لتقنية كورية لتخطيط القلب في مستشفى برجيل [3].
- تطوير مشترك لغرف عمليات ذكية من 45 متطلبًا وظيفيًا [4].
- تقييم نموذج MILTON من أستارزينيكا على سكان المنطقة [5].
- «شريك ألفا» في دبي يبني منصة يملكها المورّد [7].

يعني: المستشفيات عندنا صارت المكان الذي تُختبر فيه التقنية، لا المكان الذي تُصنع فيه.

الشكل 1: ست شراكات في ستة أيام، ولا نص معلن يحدد لمن تؤول نتائج التجربة

الجهة الخليجية	الشريك	دورها كما ورد في الإعلان	ملكية النتائج في النص المعلن
دائرة الصحة – أبوظبي [1]	Isomorphic Labs	خارطة بحث ما قبل سريري مدتها 24 شهرًا داخل «بيئة البحث الموثوقة» في أبوظبي	لم نجدها، والبحث يجري داخل بيئة أبوظبي
مستشفى برجيل [3]	ARPI (كوريا)	دراسات تحقق سريري استرجاعية واستباقية على تخطيطات قلب مجهولة الهوية	لم نجدها، والتوسع مشروط بـ«شروط يُتفق عليها»
AiMed (برجيل القابضة) [4]	Proximie	تطوير مشترك على 4 مراحل وفق 45 متطلبًا، والمنصة تعمل أصلًا في 10 غرف عمليات	لم نجدها
بنك أبوظبي الحيوي [5]	AstraZeneca	تقييم ملاءمة نموذج MILTON لسكان المنطقة، فوق أكثر من 5 ملايين عينة حيوية	لم نجدها
هيلث بوينت (M42) [6]	Proximie	أول مستشفى في شبكة M42 يطبّق المنصة في كل غرف عملياته	لم نجدها، والنتائج «قد تُسترشد بها» شبكة M42
المستشفى الأمريكي دبي [7]	HEI Global Health	«شريك ألفا» يبني منصة RevOptix التابعة للمورّد	لم نجدها، والمورّد يذكر ما يكسبه هو
للمقارنة: M42 [2]	Microsoft Azure	منصة Ossi في 7 منشآت	النص يقول إنها «مبنية على بنية M42 المملوكة» (إعلان لم نتحقق منه)

المصدر: النصوص المعلنة المرقّمة؛ قراءة VisionSeek في 27 أكتوبر 2026. «لم نجدها» تعني أنها غير مذكورة في النص المعلن، لا أنها غائبة عن العقد. المصدر [7] محتوى ترويجي منشور باسم الشركتين.

ما الذي يطلبه المنظّم، وما الذي نسيه؟

المنظّم الخليجي يطلب التحقق المحلي ويشجّعه.

معيار الذكاء الاصطناعي المسؤول الصادر عن دائرة الصحة في أبوظبي (أكتوبر 2025) يسري على الأنظمة المطوّرة داخليًا وتلك المأخوذة من مورّدين أو عبر تعاون بحثي. ويطلب التحقق قبل التشغيل، والاختبار على بيانات متنوعة، والمراقبة المستمرة [8].

ومعيارها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في فحص السل يشترط تقييمًا استباقيًا في المركز نفسه الذي سيُستخدم فيه النظام، لمدة أسبوعين على الأقل [9].

وفي السعودية، تقرّ إرشادات هيئة الغذاء والدواء بأنه «لا يوجد إطار متوافق دوليًا للتقييم السريري»، وتطلب من المصنّع إثبات صلاحية المنتج سريريًا على الفئة المستهدفة [11].

لكن هذه القواعد تجيب عن سؤال واحد.

إنها تسأل: «هل النموذج آمن عندنا؟». ولا تسأل: «لمن يبقى ما تعلّمناه؟».

في بحثنا النصي في معيار أبوظبي لم نجد بندًا عن ملكية التحسينات أو الملكية الفكرية [8]. وسياسة الدائرة تتحدث عن حماية «سرية وملكية معلومات المريض [10]»، أي البيانات، لا النموذج الذي تعلّم منها.

وفي المقابل يقول الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المورّدة صراحةً إن الشراكة «تمنح HEI رؤى تشغيلية قيّمة من الواقع» تساعد في تطوير حلولها [7].

يعني: المورّد يعرف تمامًا ماذا يكسب، والمستشفى لم يكتب بعد ماذا يكسب هو.

لماذا تجربة المستشفى غالية إلى هذا الحد؟

لأن ما ينجح عند المطوّر قد يتعثر عندك.

حين اختبرت جامعة ميشيغان نموذج إنذار تعفن الدم من Epic على 38,455 حالة دخول، هبطت دقته التمييزية (AUC، أي قدرته على التفريق بين المريض والسليم) إلى 0.63، بعد أن ذكر المطوّر 0.76 إلى 0.83. وفاته 67% من الحالات [12].

يعني: التحقق المحلي ليس مجرد إجراء ورقي، بل هو أصل ثمين يحتاجه المورّد ليبيع في المنطقة كلها.

الشكل 2: النموذج الذي ينجح عند مطوّره قد لا ينجح في مستشفاك

المؤشر	القيمة
الدقة التمييزية لنموذج Epic لتعفن الدم كما ذكرها المطوّر	0.76 إلى 0.83
الدقة نفسها عند التحقق الخارجي في ميشيغان	0.63
حالات التعفن التي فاتت النموذج	67% (1,709 من 2,552)
أجهزة ذكاء اصطناعي وافقت عليها FDA ولها دراسة استباقية	5 من 141 (3.5%)
أجهزة لم تذكر وثائقها عدد المواقع التي اختُبرت فيها	95 من 141 (67%)



المصدر: Wong وآخرون، JAMA Internal Medicine 2021 [12]؛ وقاعدة البيانات المفتوحة لـ Wu وآخرين (ستانفورد) لقرارات FDA بين 2016 و2021، وحساب النسب من VisionSeek [13].

ماذا تفعل كوريا بالأدلة نفسها؟

كوريا تبني، ومستشفياتنا تُختبر عليها التقنية.

ارتفعت موافقات وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية على أجهزة الذكاء الاصطناعي الطبية من 64 في 2023 إلى 153 في 2025، منها 119 من صنع محلي [14].

تلك صناعة تراكمت فوق أدلة سريرية، وهي الأدلة نفسها التي تقدّمها مستشفياتنا اليوم.

يعني: الدليل الذي ننتجه نحن اليوم هو ما بنت عليه كوريا صناعتها.

الشكل 3: كوريا تراكم صناعتها في بيتها، 153 موافقة في عام واحد

السنة	موافقات أجهزة الذكاء الاصطناعي الطبية	محلية	مستوردة
2023	64	55	9
2024	108	94	14
2025	153	119 (77.7%)	34 (22.3%)



المصدر: تقرير موافقات الأجهزة الطبية لعام 2025، وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية (30 أبريل 2026) [14].

ماذا يكتب صاحب القرار قبل أول مريض؟

1. **اكتبوا ملحق ملكية قبل أول مريض.** يحدد من يملك بيانات التحقق، ونتائج الدراسة وحق نشرها، وأي نسخة من النموذج تُعدَّل أو تُضبط على بياناتكم.
2. **اجعلوا التحقق بوابةً لا مجاملة.** حدّدوا مقاييس القبول قبل التجربة، وعلى مرضاكم أنتم، ولا توسيع قبل اجتيازها. معيار السل في أبوظبي يقدّم نموذجًا جاهزًا: تقييم استباقي في موقع الاستخدام لأسبوعين على الأقل [9].
3. **سعّروا دليلكم.** إذا استخدم المورّد نتائجكم في تسجيل منتجه أو تسويقه في المنطقة، فليكن المقابل مكتوبًا: ترخيص عكسي، أو سعر تفضيلي، أو حصة في العائد.
4. **اجعلوا الفريق يتعلّم لا يتفرّج.** سمّوا مالكًا داخليًا للتجربة، واشترطوا تسليم وثائق التكييف وتدريب مهندسين من فريقكم على الضبط والمراقبة. هذا ما ينقل المستشفى من درجة «الاستخدام» إلى درجة «التكييف».
5. **اكتبوا حق الخروج من اليوم الأول.** إعادة البيانات أو حذفها بشهادة، وقابلية نقل النموذج المضبوط، ومراقبة الأداء بعد التشغيل كما يطلب معيار أبوظبي [8].
6. **اطرحوا في كل اجتماع لمجلس الإدارة سؤالًا واحدًا عن كل تجربة:** ماذا سنملك لو خرج المورّد غدًا؟

قراءة VisionSeek (رأي)

أخطر ما في هذه الموجة أنها تبدو مجانية.

المورّد يأتي بالتقنية، والمستشفى يقدّم المرضى والبيانات وساعات الأطباء. لكن الدليل السريري في سوق جديدة هو أثمن ما يحمله المورّد حين يدخل أسواق المنطقة كلها.

والمستشفى الذي أنتج هذا الدليل يملك في تلك اللحظة أقوى ورقة تفاوض سيملكها على الإطلاق. بعد نجاح التجربة يصبح المورّد ضروريًا، وتضعف الورقة.

في قراءتنا، لم تصل كوريا إلى 119 جهازًا محليًا في عام واحد بحسن الشراء، بل بمستشفيات وشركات تراكم الأدلة والخبرة في الداخل.

ولا يحتاج المستشفى الخليجي إلى رفض الشريك الأجنبي. الشراكة طريق سريع ومفيد، لكن المطلوب أن يخرج المستشفى من كل تجربة وقد صعد درجة.

لهذا بنينا برنامج **VS-P03 Clause** لمراجعة عقود الذكاء الاصطناعي ومناقصاته قبل التوقيع، و**VS-P04 Relay** لصفقات نقل التقنية الكورية العربية، مثل شراكة برجيل مع ARPI، على سلّم يبدأ بالاستخدام ويطمح إلى التصميم.

الخلاصة

التجربة الأولى هي أرخص لحظة يكتب فيها المستشفى حقّه، وأغلاها إذا تركها تمرّ.

والسؤال الذي سنراقبه: هل سيكون أول مستشفى خليجي ينشر بند ملكية النتائج في شراكته القادمة؟

المنهجية والمصادر

النطاق: الإمارات (أبوظبي ودبي)، مع الإطار السعودي للمقارنة؛ الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؛ إعلانات الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2026؛ وحدة التحليل هي الإعلان المنشور. **خارج النطاق:** نصوص العقود ومذكرات التفاهم غير المنشورة، وجودة التقنيات نفسها. والعينة هي ما رصدناه، لا حصر شامل.

سلّم الامتلاك: من النصوص العامة وحدها نعدّ درجة كل شراكة «غير قابلة للتقييم». الإعلانات تصف أدوار الجهات الخليجية كمواقع تحقق ومستخدمين وشركاء تطوير، ولا تكفي لإثبات درجة أعلى.

ما لا نعرفه: قد تتضمن العقود الفعلية بنود ملكية لم تُنشر. ولم نتحقق من ادعاءات الشركات عن أدائها وانتشارها، مثل قول ARPI إن تقنيتها تُستخدم في أكثر من 150 مستشفى كوريًا [3]. وبحثنا في معايير دائرة الصحة بحث نصي في النسخ الإنجليزية المنشورة.

قائمة المصادر

[1] WAM · 2026-10-21 · DoH signs agreements to advance research in life sciences, personalised preventive health, AI drug discovery (مستوى ب/د)
https://www.wam.ae/en/article/c2us4jt-doh-signs-agreements-advance-research-life

[2] Abu Dhabi Media Office · 2026-10-21 · M42 launches Ossi (مستوى ب)
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/health/m42-launches-ossi-an-ai-platform-transforming-clinician-patient-connections/

[3] Gulf News · 2026-10-22 · Burjeel Hospital partners with South Korea's ARPI ((مستوى د (تصريحات الشركة))
https://gulfnews.com/business/corporate-news/burjeel-hospital-partners-with-south-koreas-arpi-to-advance-ai-powered-cardiac-diagnostics-1.500719377

[4] WAM · 2026-10-22 · Burjeel Holdings, Proximie collaborate (مستوى ب/د)
https://www.wam.ae/en/article/c2vdkb8-burjeel-holdings-proximie-collaborate-develop

[5] Abu Dhabi Media Office · 2026-10-22 · Abu Dhabi Biobank partners with AstraZeneca (مستوى ب)
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/health/abu-dhabi-biobank-partners-with-astrazeneca-to-advance-predictive-healthcare/

[6] M42 · 2026-10-23 · Healthpoint partners with Proximie (مستوى ب)
https://m42.ae/media-resources/news/m42-s-healthpoint-partners-with-proximie-to-bring-real-time-surgical-intelligence-to-operating-rooms-in-abu-dhabi/

[7] Gulf News · Reach · 2026-10-26 · American Hospital Dubai and HEI Global Health partner ((مستوى ب (محتوى ترويجي))
https://gulfnews.com/uae/health/american-hospital-dubai-and-hei-global-health-partner-to-build-an-ai-powered-revenue-cycle-innovation-1.500723825

[8] Department of Health – Abu Dhabi · 2025-10 · Responsible AI Standard DoH/ST/DDGO/RAI/V1/2025 (مستوى أ)
https://www.doh.gov.ae/-/media/Feature/Resources/Standards/2025/Responsible-AI-Standard-V1.ashx

[9] Department of Health – Abu Dhabi · 2025-08 · Standard for the use of AI in detecting pulmonary TB (visa screening) (مستوى أ)
https://www.doh.gov.ae/-/media/Feature/Resources/Standards/2025/050825_Standard-use-of-AI-in-detecting-PT-AD.ashx

[10] Department of Health – Abu Dhabi · Policy on Use of Artificial Intelligence in the Healthcare Sector (مستوى أ)
https://www.doh.gov.ae/-/media/E9C1470A575146B18015DEBE57E47F8D.ashx

[11] SFDA · 2023-01-03 · MDS-G010 Guidance on AI-based medical devices (مستوى أ)
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2023-01/MDS-G010ML.pdf

[12] JAMA Internal Medicine · 2021 · Wong et al. External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model (مستوى ج)
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.2626

[13] Nature Medicine + open database (Stanford) · 2021 · Wu et al. How medical AI devices are evaluated (مستوى ج)
https://ericwu09.github.io/medical-ai-evaluation/

[14] MFDS Korea (via KRIBB BioIN mirror) · 2026-04-30 · 2025 medical device approvals report (مستوى أ)
https://www.bioin.or.kr/board.do?bid=division&cmd=view&num=333704

صورة الغلاف: رسم توضيحي: VisionSeek (مولَّد)